天天师兄 展示 2017–2026 年临床医学综合能力（306）的“外科学”出题规律					
共 36 题（70 分）	共计	A_1 （57–67）	A_2 （93–107）	B （132–135）	X （160–165）
外科总论 （部分题在各论考）	3–5 题	1–3	0–3	0–2	0–3
颈部和胸部疾病	4–7 题	2–4	0–3	1–2	0–1
腹部和肠道疾病	6–9 题	1–4	2–7	0–2	1–3
肝胆胰脾疾病	7–11 题	0–3	2–7	0–4	1–3
血管和泌外疾病	0–3 题	0–2	0–2	0–2	0–1
骨科疾病	10 题	3	5	0	2

颈部和胸部疾病

考频（4–7 题，★★★）：A_1 2–4　A_2 0–3　B 1–2　X 0–1

①甲状腺疾病：甲亢外科治疗、甲状腺癌、单纯性甲状腺肿、甲状腺炎（亚甲炎和慢性淋巴细胞性）、甲状腺结节良恶性鉴别、甲状腺手术（指征和并发症）

②甲旁亢

③颈部肿块

④食管疾病：食管癌、贲门失弛缓症

⑤纵隔肿瘤

⑥~~肺癌~~

⑦胸部损伤：~~胸腔闭式引流、气胸、血胸、脓胸~~、肋骨骨折、创伤性窒息

⑧乳房疾病：乳腺癌、乳腺囊性增生病、急性乳腺炎

注意：先复习《病理学》内分泌系统疾病、生殖系统疾病、乳腺疾病相关章节，再复习外科学

核心精讲

颈部疾病

（性感认识： 理顺甲状腺相关疾病的用药和手术）

一、 甲亢的外科治疗 外科 颈部疾病 00:04:54−00:16:48

1.禁忌症：青少年、甲亢合并严重心肝肾功能不全

「理顺知识点」
- 甲状腺激素对青少年生长发育起重要作用→禁止切甲状腺
- 甲亢合并严重心肝肾功能不全→不耐受手术→禁止切甲状腺

2.手术方式：全甲状腺切除、双侧甲状腺近全切、双侧甲状腺次全切（即9 版教材的甲状腺大部切：切80−90%腺体+峡部 89 峡）

①原发性甲亢首选全切、近全切

②高功能腺瘤首选患侧叶或部分切+冰冻切片

③结甲继发甲亢：根据病变范围不同可选择腺叶部分、腺叶、次全、近全、或全切除术

「理顺知识点」
- 原发性甲亢：弥漫性毒性甲状腺肿→首选全切、近全切
- 高功能腺瘤：良性肿瘤，病变局限，不发生浸润转移→无需全切，切除良性肿瘤所在腺叶/小部分切除

3.术前准备

（1）要求：BMR＜20%、脉率＜90、情绪稳定、睡眠良好、体重增加

「理顺知识点」
- 甲状腺危象的最常见原因：术前准备不充分
- 基础代谢率 BMR↑ 判断甲亢严重程度：轻度 20−30%、中度 30−60%、重度 60%以上 236

（2）术前用药（别合成、别释放、别来刺激我心脏）

①原发性甲亢：先用抗甲状腺药、后加用碘剂 2 周（抗甲状腺药把甲状腺搞大了、通过碘剂给它擦屁股）

②继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药【十版改变】

碘剂	复方碘化钾 （卢戈 Lugol 液）	主要抑制甲状腺素释放 使甲状腺缩小变硬、充血减轻（直接拮抗 TSH）
抗甲状腺药	MMI 、PTU	抑制 TPO→ 甲状腺激素合成↓→ 甲状腺增大充血
β −R 阻断剂	普萘洛尔	适合没有条件服用碘剂、抗甲状腺药或合并心动过速者 需注意 β −R 阻断剂的禁忌症 2234都积极笑变异咯

「理顺知识点」
- 抗甲状腺药：抑制 TPO→甲状腺激素合成↓→TSH↑（负反馈）→甲状腺明显增大，不利于手术→加用碘剂（直接拮抗 TSH）→甲状腺缩小变硬、充血减轻
- 继发性甲亢、高功能腺瘤：病变局限，非弥漫病变，甲状腺不易变大，同时碘剂存在一定风险，一般无需加用碘剂

二、甲状腺癌

外科 颈部疾病
00:16:48-00:42:39

（一）类型

1.乳头状癌最常见（成人 60%、儿童 100%）小时候 100 分、长大 60 分就是幸福

①局部淋巴结转移较早、但预后最好（局部淋巴结转移与预后无关）

②多中心病灶，乳头中心砂粒体/钙化小体、毛玻璃样核、核沟（多个乳头脱毛要杀菌）

「理顺知识点」
- 抓规律：一般恶性肿瘤DNA丰富
  记特殊：甲状腺乳头状癌细胞核染色质少，呈透明毛玻璃样

2.滤泡癌早期易血道转移

注意：分化极好的滤泡癌很难与滤泡性腺瘤区别，需对肿瘤及包膜多处取材、观察是否有包膜侵犯和血管侵犯（浸润）、即依靠生物学行为鉴别

「串联」
- 最早最常见为早期血道转移：肺腺癌、绒癌、HCC、甲状腺滤泡癌
- 抓规律：一般良性肿瘤有包膜，恶性肿瘤无包膜；记特殊：甲状腺滤泡癌是恶性肿瘤但有包膜

3.髓样癌来源于滤泡旁/C 细胞（APUD）

①淀粉样变性（水一点）

②分泌降钙素致低钙血症；分泌 5-HT 等致类癌综合征（面部潮红、腹泻、多汗）

「串联」
- 与AUPD细胞（嗜银细胞/神经内分泌细胞）有关的肿瘤：小大类水一个，小细胞肺癌、大细胞神经内分泌癌，类癌，甲状腺髓样癌，胰岛细胞癌，嗜铬细胞瘤

4.未分化癌预后最差（间变）

①小、梭形、巨、混合细胞型（小说剧情混乱）

②早期易局部和远处转移

（二）检查和分期

①超声

②确诊：细针穿刺细胞学检查

③怀疑骨转移：ECT

「理顺知识点」
- 表浅器官如甲状腺、乳腺、肝、胆可使用超声检查
- 放射性核素骨扫描ECT：恶性肿瘤代谢旺盛、活跃，不断摄取核素，使影像局部发亮。敏感性高，特异性低（只能说明活跃，摄取了核素≠恶性肿瘤，炎症同样可导致发亮）

「串联」
- 易经椎旁静脉转移至脊椎骨：乳腺癌、甲状腺癌、前列腺癌、肾癌 甲乳省钱

<55 岁的分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）：

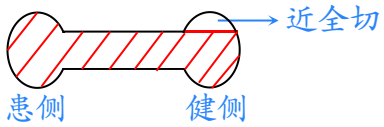
①任何 TNM_0 为 Ⅰ 期

②任何 TNM_1 为 Ⅱ 期

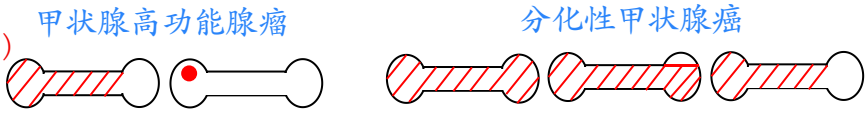
（三）治疗

1.未分化癌：外放疗

2.髓样癌：双侧全切、或患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切



3.分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）



（1）切除范围

切除范围	指征
双侧全切 或患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切 （满足任何一条）	双侧癌结节、肿瘤＞4cm、双侧颈多发淋巴结转移、有远处转移、肉眼可见的甲状腺外侵犯如甲状腺周围软组织/胸骨甲状肌/甲状舌骨肌、有颈部放射史、预后不良的病理类型如高细胞型/柱状细胞型
患侧叶全切+峡部 （全部满足）	肿瘤＜1cm、无明显临床淋巴结转移、无远处转移、无甲状腺外侵犯、无颈部放射史、无不良病理类型（＜1和五个无）

「理顺知识点」
- 病例题一般只出现肿瘤＜1cm，可选择患侧叶全切+峡部

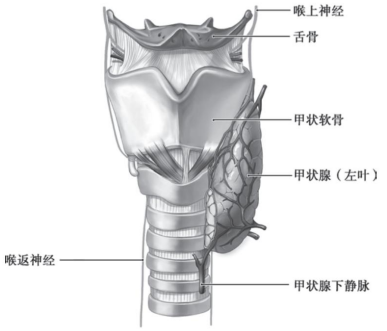


图 25-4　甲状腺腺叶(右)加峡部切除后示意图

注意：若肿瘤 1–4cm→充分评估是否有高危因素决定手术方式

（2）清扫淋巴结

①病灶同侧中央区/Ⅵ/气管旁淋巴结需清扫

②侧方淋巴结：阴性不清扫、阳性需清扫

（3）术后

①甲状腺素：预防甲减、防止复发

复发风险	抑制 TSH	一五得五、二五一十
高危	<0.1	终生抑制
中危	0.1–0.5	终生抑制
低危	0.5–2	抑制 5–10 年、后改为替代治疗

②放射 ^{131}I 内放疗：术后残留组织摄碘率＞1%

③检测是否存在早期复发：甲状腺球蛋白 TG

「理顺知识点」
- 甲状腺素→抑制TSH（TSH作用于滤泡上皮细胞，只与分化型甲状腺癌有关）
- 利用甲状腺素防止复发，所使用的甲状腺素剂量高；利用甲状腺素预防甲减，使用的甲状腺素剂量低
- 甲状腺球蛋白 TG 是合成甲状腺激素的原料，髓样癌合成降钙素，未分化癌未分化，因此仅分化型甲状腺癌可有 TG

	乳头癌	滤泡癌	髓样癌	未分化癌
TG	+	+	−	大多−
TTF	+	+	+	大多−
CT	−	−	+	−
Syn			+	

三、单纯性甲状腺肿/弥漫性非毒性甲状腺肿

外科 颈部疾病 00:42:39–00:43:55

①病因：缺碘、甲状腺素合成或分泌障碍、甲状腺素需求增多（青春期/妊娠等）

②甲状腺肿大：早期双侧弥漫肿大、后期少数可变为结甲（摸到结节）

③治疗：甲状腺素

「理顺知识点」
- 甲状腺激素↓→TSH↑（负反馈）→弥漫性甲状腺肿
- 单纯性甲状腺肿后期可进展为结节性甲状腺肿

四、结节性甲状腺肿（前世今生）

外科 颈部疾病 00:43:55−00:46:31

结甲→胸骨后甲状腺肿、继发甲亢、恶变、退变（囊性变/片状钙化/纤维化）等囊性变伴囊内出血→结节迅速增大、胀痛 vs 甲状腺癌：迅速增大不痛

「理顺知识点」
- 结甲：“前世”：单纯性甲状腺肿
  “今生”：结节性甲状腺肿可继发改变
- 结甲恶变为乳头癌，出现沙粒体，出现沙粒样钙化→怀疑恶变
- 片状钙化−营养不良性钙化，偏向良性

五、亚急性甲状腺炎/肉芽肿性/巨细胞性甲状腺炎

外科 颈部疾病 00:46:31−00:49:41

①常有 1−3 周前驱感染（病毒感染等）
②甲状腺迅速肿大、痛：单侧或双侧不对称肿大、可摸到结节（先咽痛再脖子痛）
③部分滤泡被破坏（胶质外溢）→分离现象：BMR/T_3/T_4↑、摄碘率↓
④治疗：不进行治疗可致甲减→甲状腺素；NSAIDs 或糖皮质激素抗炎止痛。抗生素无效

「理顺知识点」
- 异物巨细胞见于：异甲虫 亚甲炎、慢性血吸虫虫卵结节、异物
- 外科学病例题出现 1−3 周前驱感染→优先考虑亚甲炎（内科学病毒性心肌炎和急非特）
- 亚甲炎滤泡被破坏→甲状腺激素储存在细胞外（储存形式：胶质）→甲状腺激素外溢→类似甲亢→T_3↑、T_4↑、摄碘率↓（分离现象）

六、慢性淋巴细胞性/自身免疫性甲状腺炎/桥本

外科 颈部疾病 00:49:41−00:51:28

①甲状腺双侧弥漫肿大、质地坚韧，广泛滤泡被破坏、伴大量淋巴细胞浸润和淋巴滤泡
②甲减的表现：BMR、T_3、T_4、摄碘率均↓
③TPOAb（90%）、TGAb（60%）等
④治疗：甲状腺素

七、甲状腺结节

外科 颈部疾病 00:51:28−00:57:15

	恶性可能大	良性可能大
年龄性别	儿童（50%为恶性）、年轻男性	女性
数目	单发	多发
迅速增大	可（无痛）	少见，但腺瘤囊性变伴囊内出血可、胀痛
颈部淋巴结肿大	多有	多无
TSH	↑	正常或↓
核素	冷结节（功能低下）、血供丰富、边缘模糊	热、温、冷结节均可有

注意：TG 与甲状腺结节的良恶性无关；TSH 与甲状腺结节的良恶性有关

「理顺知识点」
- 高功能腺瘤：甲状腺激素分泌↑→TSH↓（负反馈）
- TSH↑促进分化型甲状腺癌生长

八、甲状腺相关疾病的手术（Ⅰ类清洁切口）

外科 颈部疾病
00:57:15-01:13:23

1.指征：恶变如沙粒样钙化、高功能腺瘤、中重度原发性甲亢（BMR＞30%）、结甲等继发性甲亢、胸骨后甲状腺肿、甲状腺显著肿大有压迫症状（我高中姐凶呀）

注意：妊娠期手术时机为妊娠中期（4-6 月）有手术适应症、且无手术禁忌症时（早晚要出事）

2.术后并发症

（1）甲状腺危象



①甲亢术前准备不充分（最主要）、甲亢治疗不当、感染、精神因素等应激

②高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷

③PTU（首选）、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（禁用阿司匹林）别合成、别释放、别来刺激我心脏

「理顺知识点」
- 阿司匹林：致大量出汗加重脱水，致游离 TH 增多加重病情

（2）呼吸困难和窒息（最严重）

①出血压迫气管：切口渗血、饱满。立即床旁抢救：拆线敞切口、止血清血肿，即使止血充分也应放引流

②气管软化塌陷：术前应颈部摄片

③喉头水肿：手术创伤、气管插管所致

④双侧喉返神经损伤

⑤误切甲状旁腺

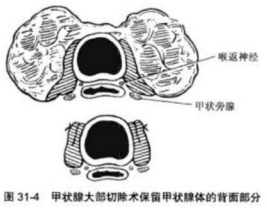


图 31-4　甲状腺大部切除术保留甲状腺体的背面部分

「理顺知识点」
- 甲状腺邻近气管，肿大的甲状腺长期压迫气管会导致气管软骨环软化，此时甲状腺对气管起到牵拉作用。当甲状腺切除术后，软化的气管壁失去支撑，发生气管塌陷
- 双侧喉返神经损伤→两侧声带动不了→声门完全关闭→窒息
- 误切甲状旁腺→PTH（升钙降磷）↓→血钙↓→Ca^{2+}的膜屏障作用↓→阈电位靠近膜电位→兴奋性↑→低钙惊厥、低钙抽搐→呼吸肌抽搐→呼吸困难、窒息

（3）神经损伤

喉上神经内支	饮水呛咳（喉黏膜感觉异常）	喝水向里面
喉上神经外支	音调降低（环甲肌瘫痪、声带松弛）	说话向外面
一侧喉返神经	声音嘶哑	一侧嘶
双侧喉返神经	失声、呼吸困难	双侧死
颈交感神经	Horner 综合征（眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、额面部胸壁无汗）	wink

结扎甲状腺上动脉要紧贴上极以避免损伤喉上神经；结扎甲状腺下动脉要远离下极和保护腺体背面以避免损伤喉返神经（拍马屁留后路）

「串联」
- 下丘脑腹内侧核：饱食中枢（拒食）内（注意题干问刺激还是破坏）
- 下丘脑外侧区：摄食中枢、摄水中枢（渴觉中枢）外面摄入
- Ortner 综合征（心脏-声带综合征）：左侧喉返神经受压致声音嘶哑（由心脏问题导致声带问题）

（4）甲状旁腺功能减退

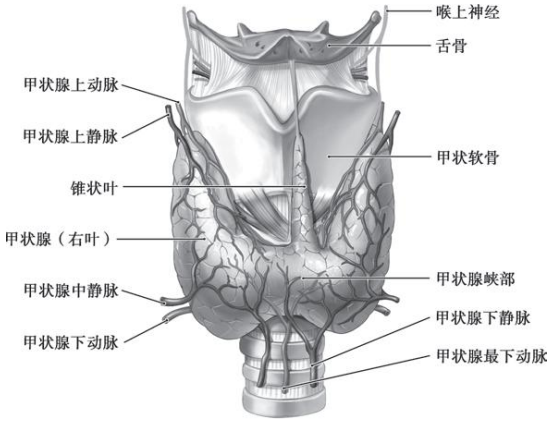
①低钙血症（离子化钙影响神经肌肉兴奋性）：针刺麻木、痉挛抽搐、腱反射亢进、Chvostek/面神经征、Trousseau 征（CT 征）、呼吸困难

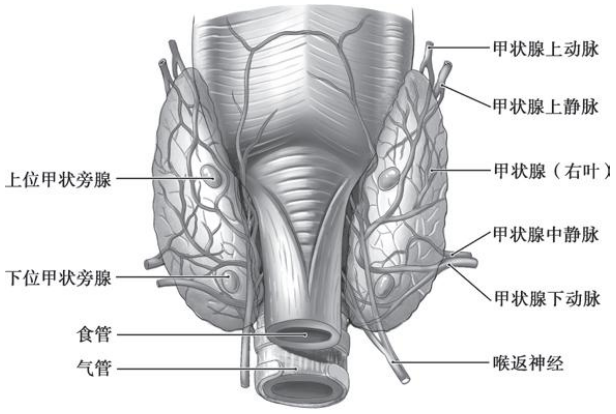
②查血钙血磷

③补充钙剂，可加服骨化三醇；保护腺体背面；若误切应移植至胸锁乳突肌

「理顺知识点」

- 保护腺体背面：既可以避免损伤喉返神经，也可以保护甲状旁腺
- 甲状腺{滤泡上皮细胞→甲状腺素；滤泡旁细胞→降钙素CT}
  甲状旁腺→PTH





九、甲状旁腺功能亢进

外科 颈部疾病 01:35:12–01:36:56

（1）单发腺瘤最多见

（2）检查

①发现甲旁亢的首要指标：血钙（高血钙、高尿钙、低血磷）

②诊断甲旁亢最可靠的指标：PTH

③定位：超声最常用、核素最准确

（3）分型

Ⅰ骨型（最多见）：骨痛、骨质疏松

Ⅱ肾型：肾结石

Ⅲ混合型

「理顺知识点」

- 大剂量 PTH 主要使破骨细胞活动增强→骨痛、骨质疏松

家家苦绝经老人在外关节骨碎骨萎

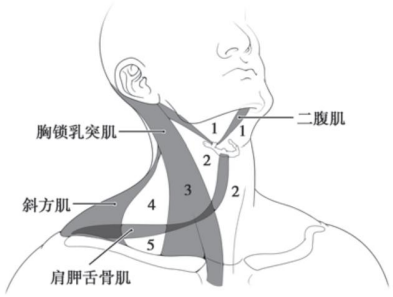


图 25-6　颈部解剖分区

颈前区：1. 颌下颏下区　2. 颈前正中区

颈侧区：3. 胸锁乳突肌区　4. 肩胛舌骨肌斜方肌区　5. 锁骨上窝

十、颈部肿块

外科 颈部疾病 01:36:56–01:38:53

	颌下颏下区	颈前正中区	颈侧区	颈后区	锁骨上窝
单发		甲状腺疾病 甲状舌管囊肿	胸腺咽管囊肿 血管瘤、淋巴管瘤 颈动脉体瘤	纤维瘤 脂肪瘤	
多发	淋巴结炎		淋巴结炎 淋巴结结核 淋巴瘤 转移性肿瘤	淋巴结炎	淋巴结结核转移性肿瘤 （占颈部恶性肿瘤的3/4）

甲状舌管囊肿：

①先天畸形，＜15 岁多见

②颈前区中线、舌骨下方的圆形囊性肿块、边界清楚、随舌头上下移动

③完整切除囊肿、并发的瘘管、部分舌骨

「理顺知识点」

- 完整切除囊肿、并发的瘘管、部分舌骨→防止复发

专题串联

外科 颈部疾病
01:13:23–01:35:12

甲状腺相关疾病的可能可能最可能和用药

	痛	迅速增大	单侧或双侧不对称肿大	双侧弥漫肿大 亢/减/非	天天师兄提示	治疗
Graves 病				√	甲状腺肿大与甲亢同时出现 多有突眼 TRAb 中的 TSAb	内科先考虑 MMI、PTU；有手术指征则手术；放射 ^{131}I
单纯性甲状腺肿				√	后期少数可变为结甲	甲状腺素 有手术指征则手术
结甲	囊变伴出血	囊变伴出血	√		可胸骨后甲状腺肿、继发甲亢、恶变、退变等	有手术指征则手术
亚甲炎	√	√	√		1–3 周前驱感染；分离现象（BMR/T_3/T_4↑、摄碘率↓）	NSAIDs 或激素
桥本				√	甲减、TPOAb 慢性淋巴细胞性/自身免疫性	甲状腺素
腺瘤	囊变伴出血	囊变伴出血	√		结节光滑，可继发甲亢	手术
腺癌		√	√		结节不平，常伴颈淋巴结肿大	手术等

「理顺知识点」

- 原发性甲亢：甲状腺肿大与甲亢同时出现
- 桥本/慢性淋巴细胞性甲状腺炎：大量淋巴细胞浸润，淋巴滤泡形成
- 高功能腺瘤可继发甲亢，核素检查为热结节
- 中重度原发性甲亢，可以采取手术治疗
- 腺瘤与腺癌的区别：切除范围不同
  腺瘤：患侧腺叶切除、部分切除
  腺癌：髓样癌：全切/近全切；
  分化型癌：全切/近全切；<1和5个无–患侧腺叶全切

小结甲状腺相关疾病的用药：

（1）Graves 病：内科题目先考虑甲巯咪唑/他巴唑 MMI（首选）、丙硫氧嘧啶 PTU（妊娠早期 1–3 月首选）。若中性粒细胞＜1.5×10^9/L 停药

（2）甲危：PTU（首选）、碘剂、普萘洛尔、氢化可的松、物理降温（禁用阿司匹林）

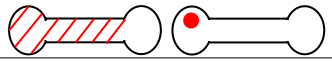
（3）甲亢术前用药

①原发性甲亢：先用抗甲状腺药（使甲状腺增大充血）、后加用碘剂 2 周（使甲状腺缩小变硬、充血减轻）

②继发性甲亢、高功能腺瘤：单用抗甲状腺药
③β-R 阻断剂
（4）碘剂可用于原发性甲亢术前用药、甲危；禁用于普通甲亢
（5）可使用甲状腺素的情况
①甲减：桥本、甲状腺手术后（甲亢、甲状腺肿瘤等）、放射 ^{131}I 治疗后、亚甲炎未经治疗
②单纯性甲状腺肿
③Graves 病使用抗甲状腺药若引起甲减或甲状腺明显增大
④分化型甲状腺癌（乳头状癌、滤泡癌）术后防复发（抑制 TSH）：高危终生至＜0.1，中危终生至0.1-0.5，低危5-10 年至 0.5-2　一五得五二五一十

「理顺知识点」
- 甲状腺危象：高热大汗、上吐下泻、谵妄昏迷，首选PTU起效比 MMI 更快，PTU可以抑制 $T_4 \rightarrow T_3$
- β-R 阻断剂：适合没有条件服用碘剂、抗甲状腺药或合并心动过速者

甲状腺高功能腺瘤



常考的甲状腺疾病切除范围：

甲亢	全切、近全切、次全切/大部切 原发性甲亢首选全切、近全切；高功能腺瘤首选患侧叶或部分切
甲状腺髓样癌、多数分化型甲状腺癌	全切、近全切（患侧叶全切+峡部+对侧叶近全切）
分化型甲状腺癌全满足（＜1和五个无）	患侧叶全切+峡部

甲状腺手术指征：我高中姐凶呀

恶变
- 结甲继发
- 甲状腺癌
  - 未分化：外放疗
  - 髓样癌：全切/近全切
  - 分化型癌：全切/近全切；<1和5个无-患侧腺叶全切+峡部
    - 术后给甲状腺素：①预防甲减②防止复发
    - 淋巴结清扫：只要是同侧中央区淋巴结不论阴性/阳性，都常规清扫
      侧方淋巴结阳性清扫阴性不清扫

高功能腺瘤



- 术前：BMR＜20%、用抗甲状腺药，合并心动过速用β-R拮抗剂

中重度原发性甲亢/Graves病
- 多在内科考察，内科治疗无效则在外科考察
- 采用全切/近全切。术前使用抗甲状腺药+碘剂

结甲继发甲亢
- 根据结节范围采用切除术
- 术前使用抗甲状腺药，合并心动过速用β-R拮抗剂

术前用药：合并心动过速用β-R拮抗剂，注意禁忌症

胸骨后甲状腺肿压迫

真题解析 · 颈部疾病

外科 颈部疾病
01:38:53-02:08:43

1.2013N81 A 女性，55 岁。因结节性甲状腺肿行双侧甲状腺次全切除术，术后病理报告，右叶甲状腺有 5mm 乳头状癌结节。该患者进一步的处理是 5mm<1cm 患侧腺叶全切+峡部

A.切除右叶甲状腺加颈淋巴结清扫 同侧中央区淋巴结不论阴性/阳性，都常规清扫

B.手术切除剩余的右叶甲状腺

C.终生口服甲状腺素钠

D.加用外照射治疗

2.2014N82 A 女性，29 岁。因右侧甲状腺结节行手术治疗，术中见甲状腺右叶直径 1.5cm 囊实性结节，未触及肿大淋巴结，冰冻切片提示甲状腺乳头状癌。该患者应采取的手术方式是

直径 1.5cm 囊实性结节＞1 全切/近全切

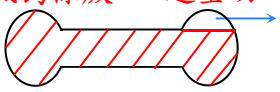
A.甲状腺近全切除术

B.甲状腺全切及颈淋巴结清扫术 同侧中央区淋巴结常规清扫

C.右侧腺叶切除术

D.右侧腺叶加峡部切除术

3.2015N116-117 A 女性，37 岁。因左叶甲状腺乳头状癌行甲状腺左叶全切、峡部及右叶大部切除术。术后第 1 天发生呼吸急促，口周麻木，手足持续性痉挛。低钙惊厥　近全切



116.为明确诊断，应首选的检查是

A.血 T3 、T4

B.颈部 B 超

C.颈部穿刺

D.血清钙、磷浓度

117.首要的处理措施是

A.静脉注射钙剂

B.气管切开

C.拆除颈部伤口缝线

D.检查引流管

4.2016N81 A 女性，29 岁，因右侧甲状腺结节手术，术中见甲状腺右叶多个囊实性结节，颈部无肿大淋巴结，行右叶全切除术。术后病理报告提示甲状腺内有 5mm 乳头状癌灶。对该患者进一步的处理方案是 5mm 乳头状癌灶＜1→切患侧叶全切+峡部

A.口服甲状腺素 预防甲减、抑制 TSH 防止肿瘤复发

B.峡部及左叶部分切除术

C.甲状腺近全切除术

D.甲状腺全切及颈淋巴结清扫术

5.2017N59 A 男性，45 岁。因甲状腺癌行左叶甲状腺全切术，术后出现饮水呛咳，但发音正常。首先考虑的原因是

A.喉返神经损伤

B.交感神经损伤

答案：1-5 A/C B DA A D

C.喉上神经外支损伤 说话向外面
D.喉上神经内支损伤 喝水向里面

6.2017N132−133 B
A.普萘洛尔
B.复方碘溶液
C.丙硫氧嘧啶
D.醋酸泼尼松
能使甲亢患者甲状腺体积缩小，质地变硬的药物为
能使甲亢患者甲状腺体积增大，充血的药物为

7.2018N64 A 女性，35 岁，甲状腺乳头状癌根除术后 1 天，发现饮水时呛咳，说话音调低。最可能的原因
A.声带损伤
B.喉上神经损伤
C.喉返神经损伤
D.插管所致声门水肿

压迫症状
8.2018N93−95 A 女性，40 岁，患有甲状腺结节 10 年，近年来易出汗，心悸，渐感呼吸困难。查体：脉搏 104 次/分，BP 130/70mmHg，无突眼，甲状腺Ⅲ度肿大，结节状。心电图示：窦性心律不齐。 结甲继发甲亢无突眼
93.最可能的诊断是
A.原发性甲亢
B.单纯性甲状腺肿
C.继发性甲亢
D.桥本甲状腺炎

94.为明确诊断，主要的依据是 明确甲亢诊断
A.颈部 CT
B.血清 T3 、T4 、TSH 值
C. 甲状腺 B 超
D.颈部 MRI

95.该患者首选的治疗措施是 我高中姐凶呀
A.抗甲状腺药物治疗
B. 甲状腺大部切除术
C. 甲状腺全切术
D. 同位素治疗

- 手术
  - 甲亢
    - Graves病：全切/近全切
    - 高功能腺瘤：患侧+峡部、部分切除
    - 结甲继发甲亢：看情况
  - 甲状腺癌
    - 未分化：外放疗
    - 髓样癌：全切/近全切
    - 分化型癌：全切/近全切；<1和5个无−患侧腺叶全切+峡部
      - 同侧中央区淋巴结常规清扫
      - 侧方淋巴结阳性清扫阴性不清扫

答案：6-8 BC B CBB/C

9.2018N132-133 B

A. 胃癌

B.结肠癌

C. 甲状腺乳头状癌

D.胰腺导管腺癌

患者术后一般能存活 15 年以上的肿瘤是 幸福癌

患者术后很少存活 5 年的肿瘤是 癌中之王

10.2019N58 A 女性，42 岁，无痛性甲状腺肿大 3 个月。查体：甲状腺弥漫性肿大，触诊质地较硬、韧， 表面光滑。化验：T_3、T_4 略低于正常。最可能的诊断是

A.单纯性甲状腺肿

B.慢性淋巴细胞性甲状腺炎

C.亚急性甲状腺炎

D.甲状腺癌

- 痛
  - 亚甲炎
  - 囊内出血：结甲、甲状腺腺瘤囊变
- 不痛
  - 弥漫肿大
    - T3、T4↑、BMR↑、摄碘率↑、弥漫肿大、TRAb→Graves病
    - T3、T4↓、BMR↓、摄碘率↓、弥漫肿大、TPOAb→桥本
    - 甲功正常、弥漫肿大→单纯性甲状腺肿
  - 不对称肿大
    - 结甲：多发、无包膜、前世（单纯性甲状腺肿）今生（继发甲亢、恶变、囊变）
    - 甲状腺腺瘤：单发、有包膜、可以是高功能腺瘤
    - 甲状腺腺癌：单发、无包膜（除滤泡癌）、凹凸不平、淋巴结肿大、短期迅速增大但无痛

11.2019N162 X 下列甲状腺疾病中可用甲状腺素治疗的有

A.甲状腺癌根治术后 预防甲减、防止复发

B.亚急性甲状腺炎

C.慢性淋巴细胞性甲状腺炎

D.20 岁以下弥漫性单纯性甲状腺肿

12.2020N97-99 A 女性，53 岁。诊断结节性甲状腺肿 2 年，近日突觉颈部胀痛，复查 B 超见左叶结节较 1 年前增大，直径由 1.8cm 变为2.6cm，呈囊实性，部分囊壁可见片状钙化。

97.可能的诊断是

A.恶性变

B.囊内出血

C.桥本甲状腺炎

D.亚急性甲状腺炎

98.此时最适宜的处理是

A.对症治疗

B.甲状腺大部切除术

C.穿刺抽液

D.甲状腺结节切除术

答案：9-12 CD B ABCD BAD

99.两年后复查 B 超发现右叶腺体有沙粒样钙化。拟行的治疗方案是
A.继续保守治疗
B.右叶全切除术 +峡部
C.双叶次全切除术
D.右叶全切、左叶次全切除术

13,2021N132−133 B
A.髓样癌
B.未分化癌
C.滤泡状癌
D.乳头状癌
分泌降钙素的甲状腺癌是
临床最多见的甲状腺癌是

14.2022N60 A 预防甲亢术后甲状腺危象最关键的措施是
A.术后应用镇静药物
B.吸氧
C.术后给予氢化可的松
D.术前使基础代谢率降至正常范围 <20%

15.2022N97−99 A 男，50 岁。行甲状腺癌根治术，术后 10 小时开始感呼吸困难，心悸。查体：R 32 次/分，BP 140/92mmHg，心率 124 次/分，切口处饱满。
97.目前最可能出现的情况是
A.喉头痉挛
B.声带麻痹
C.甲状旁腺危象
D.创面血肿

98.应立即采取的措施是
A.急查 B 超
B.急查血钙
C.立即拆线敞开切口 拆线敞切口、止血清血肿
D.急查喉镜

99.进一步的处理措施是
A.补钙
B.手术探查止血
C.吸氧，密切观察
D.应用糖皮质激素

16.2023N62 A 女性，40 岁。发现颈部肿物伴疼痛 3 天就诊。查体：左颈前可触及直径 3cm 肿物，边界清，质韧，光滑，可随吞咽移动，触痛(+)。最可能的诊断是
A.亚急性甲状腺炎

答案：13-16 AD D DCB C

B. 甲状舌管囊肿
C. 甲状腺腺瘤囊内出血
D. 甲状腺癌

17.2023N134−135 B
A.损伤喉返神经　一侧嘶 双侧死
B.损伤喉上神经内支
C.损伤喉上神经外支
D.损伤颈交感干
甲状腺术后，出现饮水呛咳的原因是
甲状腺术后，出现声音嘶哑的原因是

18.2024N60 A 下列关于甲状腺髓样癌的叙述，错误的是
A.临床较少见
B.起源于甲状腺滤泡上皮 滤泡旁细胞
C.分泌降钙素
D.可兼有淋巴和血行转移

19.2025N63A 符合甲状腺癌行双侧腺叶全切手术适应证的是
A.肿块直径 2cm
B.肿块在腺体内
C.双侧颈部淋巴结转移
D.无颈部放射史

　答案：17 - 19 BA B C